

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1302

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ד), בסופו יבוא "שר הבריאות יקבע הוראות לעניין זמן סביר ולעניין מרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, הוראות כאמור יפורסמו באתרי האינטרנט של משרד הבריאות ושל קופות החולים".
2. בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ד) לא ניתנו שירותי בריאות בזמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של המבוטח, לפי הוראות סעיף 3, בידי קופת החולים או בידי נותן שירות של הקופה או מטעמה זכאי המבוטח לקבל את שירותי הבריאות בבית חולים אחר או במרפאה אחרת, לרבות בידי נותן שירותים של קופת חולים אחרת, ובעלות הכספית תישא הקופה."

דבר ה ס בר

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, נקבעה רשימה של השירותים שיינתנו בסל הבריאות, אולם החוק הותיר גמישות בקביעת רמת הזמינות והאיכות של השירותים כשקבע כי השירותים יינתנו "באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופת החולים".

ההגדרה הגמישה מאפשרת באופן מעשי לא פעם פגיעה במבוטחים המתבטאת בתורים ארוכים לניתוחים אלקטיביים (קבועים מראש, שאינם חירום) וליועצים מומחים, ולעיתים גם בזמינות גאוגרפית נמוכה עקב העדפה של הקופה לעבוד עם ספק רחוק המציע שירות זול יותר.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

זמני המתנה ארוכים פוגעים באיכות הטיפול המוצע למבוטחים, מגבירים את הסבל הכרוך בהתמשכות המצב הרפואי ואת אי הוודאות הכרוכה בהיעדר אבחון, ובנוסף לכך פוגעים באמון הציבור וביכולתה של המערכת הציבורית לענות על צרכיו וציפיותיו. בחלק מהמקרים חלה גם הרעה בתסמיני המטופל והחמרה במצבו הרפואי בתוך תקופת ההמתנה.

סקר של ההסתדרות הרפואית מפברואר 2020 חשף זמן המתנה בלתי סביר לניתוחים אלקטיביים, שהגיע עד לשנתיים המתנה בפריפריה הצפונית לניתוח שקדים בילדים ומבוגרים, 11 חודשים לניתוח קטרקט וחצי שנה לניתוחי בקע ומפרק ירך.

בדו"ח של מרכז טאוב "מחכים לטיפול: תורים בבתי חולים בישראל" (פורסם ב-22/11/2016) נרשם כי התורים הארוכים ביותר נרשמו בדרום ובצפון הארץ ובבתי החולים של קופת חולים כללית. ניתן לראות הבדלים גם בזמני ההמתנה בין הפריפריה לבין המרכז ובין קופות חולים שונות, כשזמני ההמתנה בפריפריה ארוכים יותר מזמני ההמתנה במרכז הארץ. זמני ההמתנה הארוכים בפריפריה תואמים את משאבי הבריאות המצומצמים המוקצים לאזורים אלו, כגון היצע מיטות האשפוז בבתי החולים ומספר הרופאים בהם.

יצוין כי כבר כיום מכיר משרד הבריאות בעצם העיקרון הקבוע בהצעת החוק, ולכן מוגדרים זמני המתנה סבירים לניתוחים אלקטיביים חשובים. ניתוח אונקולוגי, ניתוח כלי דם, צנתור, מוח, לב, שתל ודיאליזה נקבע פרק זמן של עד 21 עד 30 ימים. אם הקופה לא עמדה בזמן הקבוע שקבע משרד הבריאות, יכול המבוטח לקבל הפניה לכל ספק שירות מורשה אחר שיוכל להציע לו זמן המתנה קצר יותר. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1145/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/52/24). הצעת החוק זהה לפ/52/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)